

TEMA 3.2 • UROLOGÍA

Uropatía Obstructiva Baja

PERFIL EUNACOM 1.14.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **Uropatía Obstructiva Baja** es un conjunto de alteraciones estructurales o funcionales que impiden el flujo normal de orina desde la vejiga hacia el exterior. Es una de las consultas más frecuentes en urología, especialmente en hombres adultos mayores, siendo la **Hiperplasia Prostática Benigna (HPB)** su causa principal.

Clínica: Síntomas del Tracto Urinario Inferior (STUI)

El cuadro clínico se divide clásicamente en dos grupos de síntomas que suelen coexistir.

1. Síntomas Obstructivos (Vaciado)

Suelen ser los síntomas iniciales y se deben a la resistencia mecánica al flujo. - **Disuria de esfuerzo:** Necesidad de pujar para iniciar o mantener la micción. - **Disminución del calibre y fuerza del chorro.** - **Latencia:** Demora de varios segundos antes de que comience a salir la orina. - **Intermitencia:** El chorro se corta y vuelve a empezar durante la misma micción. - **Goteo terminal:** Persistencia de salida de gotas tras finalizar el chorro principal.

2. Síntomas Irritativos (Llenado)

Se producen por la respuesta de la vejiga a la obstrucción crónica. - **Polaquiuria:** Aumento de la frecuencia miccional diurna. - **Nicturia:** Necesidad de despertar varias veces en la noche para orinar. - **Urgencia miccional:** Deseo súbito e imperioso de orinar. - **Incontinencia urinaria:** Puede ser de dos tipos: - **Por rebalse:** La vejiga está tan distendida que "rebalsa" ante pequeños aumentos de presión. - **De urgencia:** Debido a la inestabilidad del detrusor.

Ventaja: Evitan la progresión de la enfermedad y reducen el tamaño prostático a largo plazo. - **Desventaja:** Efectos adversos sexuales (disfunción eréctil, disminución de la libido). - **Inhibidores de la Fوسفodiesterasa 5 (Sildenafil):** Pueden usarse en pacientes que presentan HPB y disfunción eréctil concomitante.

Tratamiento Quirúrgico

Se indica cuando falla el tratamiento médico o cuando aparecen complicaciones.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Las 6 Indicaciones de Cirugía en HPB: 1. Infecciones urinarias recurrentes. 2. Hematuria recurrente (atribuible a la próstata). 3. Litiasis vesical o ureteral secundaria a estasis. 4. Insuficiencia renal crónica post-renal. 5. Hidroureteronefrosis (dilatación de la vía urinaria). 6. Retención Aguda de Orina (RAO) recurrente o tras fracaso de retiro de sonda.

Tipos de Cirugía según el Volumen Prostático

TABLA 3.2.1: VOLUMEN PROSTÁTICO VS TÉCNICA DE ELECCIÓN

VOLUMEN PROSTÁTICO	TÉCNICA DE ELECCIÓN	CONSIDERACIONES
< 80 cc	RTU de Próstata (Resección Transuretral)	Estándar de oro. Mínimamente invasiva.
> 80 cc	Cirugía Abierta o Laparoscópica	Evita el riesgo de absorción masiva de líquido de irrigación.
Cualquier tamaño	RTU Láser	Permite tratar próstatas grandes con menor riesgo de sangrado y sin riesgo de síndrome post-RTU.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Síndrome Post-RTU: En cirugías largas con técnicas antiguas, se puede absorber el medio de irrigación hipotónico (glicina), provocando **hiponatremia dilucional** grave y edema cerebral. Las técnicas modernas (bipolar o láser) han reducido drásticamente este riesgo.

Estenosis Uretral

Es la disminución del lumen de la uretra debido a procesos de cicatrización. Debe sospecharse ante síntomas obstructivos en pacientes con antecedentes específicos.

Factores de Riesgo / Etiología

- Antecedente de instrumentación previa (ej. una RTU de próstata anterior). - Antecedente de **Uretritis Gonocócica** (genera gran inflamación y cicatrización). - Traumatismos en el periné (clásico en accidentes de bicicleta o caídas "a horcajadas").

Diagnóstico y Manejo

- **Estudio de elección:** **Uretrocistografía retrógrada** (permite ver la localización y longitud de la estenosis) o uretroscopía. - **Tratamiento:** - Generalmente quirúrgico por vía endoscópica (Uretrotomía interna). - En casos complejos, largos o recidivantes: **Reconstrucción uretral** (Uretroplastia).

Consideraciones sobre el APE Elevado

- Es un error común pensar que un APE (Antígeno Prostático Específico) elevado es indicación de cirugía de HPB.
- El APE elevado obliga a descartar un **Cáncer de Próstata**.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología de la "Vejiga de Lucha": Ante la obstrucción, el músculo detrusor de la vejiga realiza un esfuerzo crónico para vencer la resistencia, lo que provoca una **hipertrofia de sus paredes**. Esta vejiga engrosada pierde distensibilidad y se vuelve inestable, lo que explica los síntomas irritativos y la urgencia.

Diagnóstico y Estudio

El diagnóstico de la uropatía obstructiva baja es fundamentalmente **clínico**. El estudio complementario busca confirmar la repercusión y descartar diagnósticos diferenciales.

- **Descartar Infección del Tracto Urinario (ITU):** Un cuadro de ITU puede mimetizar tanto síntomas obstructivos como irritativos.
- **Antígeno Prostático Específico (APE):** Se solicita como screening para **Cáncer de Próstata**, no para diagnosticar HPB.
- **Ecografía Básica Prostatovesical:**
 - **Residuo Post-miccional:** Es la variable más importante para objetivar y confirmar la obstrucción.
 - **Grosor de la pared vesical:** Identifica signos de "vejiga de lucha".
 - **Volumen prostático:** Ayuda a orientar la causa y el tipo de cirugía, aunque no siempre se correlaciona con el grado de obstrucción (una próstata pequeña puede ser muy obstructiva si crece hacia la uretra).

Manejo de la Hiperplasia Prostática Benigna (HPB)

El tratamiento depende de la severidad de los síntomas y la presencia de complicaciones.

Tratamiento Médico

- **Observación y Educación:** En pacientes asintomáticos o con síntomas muy leves (hallazgo ecográfico). - **Alfa-bloqueantes (Tamsulosina):** Es el fármaco de **primera línea**. Relaja el músculo liso del cuello vesical y la próstata. Actúa de forma rápida. - **Inhibidores de la 5-alfa reductasa (Finasteride, Dutasteride):** Bloquean la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. -

- La conducta ante un APE alterado es la **Biopsia Prostática Transrectal**.
- La HPB puede elevar discretamente el APE por el volumen glandular, pero el manejo de la obstrucción sigue las mismas reglas ya mencionadas.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de sesenta y ocho años, sexo masculino, consulta por disminución del calibre del chorro miccional, latencia para iniciar la micción y nicturia de tres a cuatro veces por noche desde hace seis meses. La ecografía vesico-prostática muestra un residuo postmiccional de ciento veinte mililitros y próstata de sesenta cc. El APE es de seis punto dos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Uropatía Obstructiva Baja. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Los síntomas obstructivos de la uropatía obstructiva baja incluyen disuria de esfuerzo, disminución del calibre del chorro, latencia, intermitencia y goteo terminal
- El residuo postmiccional evaluado por ecografía vesico-prostática es la variable más importante para confirmar la uropatía obstructiva baja
- La hiperplasia prostática benigna asintomática solo se observa; con síntomas el tratamiento de primera línea son los alfa bloqueantes, siendo la tamsulosina el de elección
- Las indicaciones de cirugía en hiperplasia prostática benigna son: falla al tratamiento farmacológico, infecciones urinarias recurrentes, hematuria recurrente, litiasis, insuficiencia renal, hidroureteronefrosis o retención aguda de orina
- La cirugía de elección en próstatas menores de ochenta cc es la resección transuretral; en mayores de ochenta cc se prefiere cirugía abierta o laparoscopia, aunque la RTU láser permite tratar próstatas grandes
- El APE elevado en hiperplasia prostática benigna no modifica el manejo de la hiperplasia sino que obliga a descartar cáncer de próstata con biopsia transrectal
- La estenosis uretral se asocia a RTU previa, uretritis gonocócica o trauma perineal; el examen diagnóstico de elección es la uretrositografía retrógrada y el tratamiento es endoscópico con nueva RTU

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (UROPATÍA OBSTRUCTIVA BAJA)**PREGUNTA 1**

Paciente de sesenta y ocho años, sexo masculino, consulta por disminución del calibre del chorro miccional, latencia para iniciar la micción y nicturia de tres a cuatro veces por noche desde hace seis meses. La ecografía vesico-prostática muestra un residuo postmiccional de ciento veinte mililitros y próstata de sesenta cc. El APE es de seis punto dos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Iniciar tamsulosina y solicitar biopsia prostática transrectal por el APE elevado
- B)** Indicar cirugía de inmediato por el residuo postmiccional elevado
- C)** Iniciar tamsulosina y repetir el APE en seis a ocho semanas antes de decidir sobre biopsia
- D)** Solo observar ya que la hiperplasia prostática benigna asintomática no requiere tratamiento
- E)** Iniciar finasteride como primera línea por su capacidad de reducir el volumen prostático

PREGUNTA 2

Paciente de setenta y dos años con hiperplasia prostática benigna en tratamiento con tamsulosina desde hace un año. Consulta por hematuria macroscópica en tres oportunidades en los últimos cuatro meses, infección urinaria confirmada hace dos meses y nueva infección urinaria confirmada en el control actual. La ecografía muestra próstata de noventa y cinco cc. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Agregar finasteride al tratamiento actual y controlar en seis meses
- B)** Indicar cirugía por falla al tratamiento farmacológico e infecciones recurrentes
- C)** Cambiar tamsulosina por sildenafil y agregar antibioterapia prolongada
- D)** Realizar biopsia prostática transrectal por las infecciones urinarias recurrentes
- E)** Mantener tamsulosina y derivar a nefrología por posible insuficiencia renal

PREGUNTA 3

Paciente de cuarenta y cinco años consulta por síntomas de uropatía obstructiva baja de tres meses de evolución. Refiere haber tenido una uretritis por gonorrea hace seis meses tratada correctamente. ¿Cuál es el examen diagnóstico de elección para evaluar la causa de sus síntomas?

- A)** Ecografía vesico-prostática para evaluar residuo postmiccional y próstata
- B)** APE para descartar cáncer de próstata como causa de los síntomas
- C)** Uretrositografía retrógrada para evaluar la uretra
- D)** Sedimento de orina y urocultivo para descartar infección urinaria activa
- E)** Biopsia prostática transrectal para confirmar el diagnóstico

RESUMEN: UROPATÍA OBSTRUCTIVA BAJA

La uropatía obstructiva baja es un cuadro clínico producido por la obstrucción a nivel de la uretra o el cuello vesical, que genera una mezcla de síntomas obstructivos e irritativos. Los síntomas obstructivos, más frecuentes e iniciales, incluyen disuria de esfuerzo, disminución del calibre del chorro miccional, latencia para iniciar la micción, intermitencia del chorro y goteo terminal. Los síntomas irritativos se deben a la vejiga de lucha, con paredes hipertrofiadas, y se manifiestan como polaquiuria, nicturia, incontinencia de urgencia e incontinencia por rebose. La causa más frecuente en hombres es la hiperplasia prostática benigna y la segunda el cáncer de próstata. El diagnóstico es clínico y el estudio va orientado a identificar la causa y el grado de severidad, siendo el residuo postmiccional evaluado por ecografía vesico-prostática el parámetro más importante. Siempre hay que descartar infección urinaria y solicitar APE para screening de cáncer de próstata. El manejo de la hiperplasia prostática benigna depende de si es sintomática. Si es asintomática y es un hallazgo, simplemente se observa. Si hay síntomas, el tratamiento farmacológico de primera línea son los alfa bloqueantes, siendo la tamsulosina el más usado. Los inhibidores de la cinco alfa reductasa como finasteride o dutasteride pueden prevenir la progresión pero generan disfunción eréctil y sexual. El sildenafil es una opción en pacientes que además tienen disfunción eréctil. La cirugía está indicada cuando no responde al tratamiento farmacológico o cuando hay complicaciones: infecciones urinarias recurrentes, hematuria recurrente, litiasis vesical, insuficiencia renal crónica o hidroureteronefrosis, y retención aguda de orina. La cirugía de elección depende del tamaño prostático: para próstatas menores de ochenta cc se usa la resección transuretral, y para próstatas mayores de ochenta cc la cirugía abierta o laparoscopia, aunque las técnicas láser permiten hoy manejar próstatas grandes por vía endoscópica. La estenosis uretral es otra causa importante de uropatía obstructiva baja, con el mismo cuadro clínico pero con antecedente de resección transuretral previa, uretritis gonocócica o trauma perineal. El examen diagnóstico de elección es la uretrositografía retrógrada o la uretroscopia. El tratamiento es la resección transuretral endoscópica cuando es posible, o la reconstrucción uretral en casos más graves con obliteración extensa. Un APE elevado no modifica el manejo de la hiperplasia prostática benigna, sino que obliga a descartar cáncer de próstata con biopsia transrectal.